Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Buíque

AV JONAS CAMELO, S/N, Forum Dr. João Carlos Ribeiro Roma, Centro, BUÍQUE - PE - CEP: 56520-000 - F:(87) 38552832

Processo nº 0000879-91.2022.8.17.2360

AUTOR(A): QUITERIA SALGADO DA SILVA OLIVEIRA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência, ajuizada por QUITÉRIA SALGADO DA SILVA OLIVEIRA em face do ESTADO DE PERNAMBUCO.

Aduz a parte autora, em síntese, que foi acometida de Mielofibrose com Pancitopenia em sangue periférico (CID 10 C94.5), um tipo raro de câncer no sangue, diagnosticada em 2021, já com doença metastática para osso; foi iniciado tratamento com medicações Prednisona e Eritropoietina, contudo não tiveram eficácia satisfatória, persistindo os sintomas da doença; foi-lhe prescrito o medicamento RUXOLITINIBE 15mg, que tem registro na ANVISA sob o nº 1006811210019, na dosagem inicial de 15MG na proporção de 60 comprimidos por mês, devendo tomar 02 comprimidos de 12/12 horas diariamente; o custo aproximado do Ruxolitinibe 15mg é de R$ 25.450,00 por caixa com 60 cápsulas, sendo este o custo mensal do tratamento; a autora buscou no Sistema Único de Saúde a medicação objeto da demanda, visto que não tem condições financeiras de adquirir por conta própria, obtendo como resposta a recusa, pois o Ruxolitinibe não é fornecido dado o seu elevado preço; a autora é hipossuficiente, não possuindo recursos para arcar com tal medicamento, impossibilitando o seu tratamento; a falta do medicamento está acarretando sérios prejuízos à saúde da parte autora, inclusive com o comprometimento do tratamento, que pode resultar na sua morte.

O pedido foi instruído com documentos.

Requisitadas informações, o parecer técnico inicial confeccionado pelo núcleo especializado foi desfavorável, sendo indeferido o pedido liminar.

Regularmente citado, o Ente réu apresentou contestação, arguindo preliminares de: (i) incorreção do valor atribuído à causa, argumentando que ações de saúde envolvem obrigações de fazer sem conteúdo econômico, devendo o valor ser simbólico de R$ 1.000,00; (ii) necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 793 do STF, defendendo que a União Federal deve integrar o polo passivo da demanda por se tratar de medicamento oncológico não incorporado ao SUS. No mérito, sustentou: ausência de laudo médico circunstanciado conforme exigido pela tese do STJ no REsp 1.657.156 (Tema 106); que o medicamento RUXOLITINIBE não foi incorporado ao SUS pela

CONITEC após avaliação que concluiu pela ausência de evidências científicas de eficácia; defendeu os princípios da medicina baseada em evidências; alegou violação aos princípios da isonomia, universalidade e integralidade do SUS; sustentou que o direito à saúde deve ser realizado coletivamente e não individualmente.

Houve réplica.

Posteriormente foram requisitados, sucessivamente, dois novos pareceres técnicos ao NATJUS, totalizando três pareceres técnicos no curso do processo, todos manifestando-se desfavoravelmente ao pleito autoral, sendo as partes regularmente intimadas para manifestação.

É o relatório. **Decido**.

Verifico que o feito se encontra pronto para julgamento, sobretudo por não haver a necessidade de produção de outras provas, em atenção ao art. 355 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que as alegações das partes e os documentos colacionados aos autos são suficientes para a cognição exauriente própria do julgamento. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz. Em verdade, o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a demanda quando o acervo documental for suficiente para nortear e instruir seu entendimento, sem que tal medida implique em cerceamento de defesa. Nesse sentido:

> "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares ventiladas pelo demandado.

O Réu arguiu preliminar acerca da solidariedade dos entes públicos em demandas de saúde, pugnando pela inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

O pedido não merece acolhida, por se tratar de obrigação solidária dos entes federados, conforme dispõe o precedente vinculante exarado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral:

> **Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde**, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Repercussão Geral – Tema 793) (Info 941).

Trata-se, também, de entendimento sumulado pelo E. Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> **Súmula 130/TJPE - A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.**

Com efeito, a responsabilidade solidária confere ao usuário a faculdade de escolha do responsável para o cumprimento da obrigação. O ressarcimento daquele que tem a obrigação primária do fornecimento deve ocorrer extrajudicial ou judicialmente.

Inobstante, o Tema nº 1234 do STF definiu, dentre outras coisas, que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na lista do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos. Ocorre que houve modulação dos efeitos do referido julgamento, estabelecendo que tal critério de competência se aplica apenas às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento, o que não é o caso dos autos, afastando a necessidade de inclusão da União. Nesse sentido:

> DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. DIREITO À SAÚDE. TEMAS Nº 6 E 1.234, AMBOS DO STF. Procedência desatada na origem em ordem a determinar o fornecimento do fármaco nominado "Canabidiol CBD Prati-Donaduzzi 20mg/ml, ou equivalente, observados os princípios ativos e as substâncias pleiteadas", conforme prescrição médica. Apelo dos entes estatal e municipal. Reexame necessário que se tem por interposto à força da Súmula 490 do STJ ante o caráter ilíquido da condenação. 1. **Fármaco não incorporado no SUS, com registro ou autorização sanitária para importação pela ANVISA. Temas nº 6 e 1.234, ambos do STF. Competência da Justiça Federal descortinada somente quanto o valor do tratamento anual do fármaco for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC. Modulação dos efeitos da decisão. Aplicação apenas às demandas ajuizadas após a publicação do julgamento. Competência da Justiça Estadual preservada,** reconhecida a impossibilidade de suscitação de conflito negativo de competência para processos anteriores. 2. Requisitos para o fornecimento de medicamentos estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes 60 e 61, do Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas nº 1234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral, de observância imperativa, na forma do art. 927, II e III do CPC. Impossibilidade do Poder Judiciário "fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação". Indispensável o preenchimento cumulativo dos requisitos delineados nas teses firmadas pelo STF ao tempo dos julgamentos dos Temas nº 6 e 1.234, consoante Súmula Vinculante nº 61, cujo ônus probatório incumbe à parte autora da ação. 3. Necessidade, para mais, de se aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, a partir da prévia consulta ao

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), além da análise quanto à eventual ilegalidade ou ausência de pedido de incorporação pela Conitec e comprovação científica, à luz da medicina baseada em evidências, acerca da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento para o tratamento da autora, na forma definida pelo Pretório Excelso no julgamento dos precedentes vinculantes. 4. Anulação da sentença que se impõe. Recursos voluntários e oficial prejudicados. (TJ-SP - Apelação Cível: 10113668920248260224 Guarulhos, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 31/01/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2025)

Seguindo, o demandado apresentou impugnação ao valor da causa, pleiteando sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais). Tal preliminar também não merece melhor sorte.

O art. 292 do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor. No caso em tela, embora se trate de obrigação de fazer (fornecimento de medicamentos/insumos), o conteúdo econômico da demanda deve refletir, em termos pecuniários, a prestação jurídica almejada.

O impugnante não logrou êxito em demonstrar que o custo do tratamento seria inferior ao valor indicado na inicial, limitando-se a formular alegações genéricas quanto à necessidade de redução. Ressalte-se que nas ações que versam sobre fornecimento de medicamentos/insumos, o valor da causa deve corresponder à dimensão econômica do direito material em discussão, representado pelo custo do tratamento pleiteado.

Não havendo outras questões preliminares, passo ao exame do mérito.

É importante ressaltar que o direito à saúde constitui direito fundamental social, previsto expressamente nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em suas três esferas federativas, garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar casos envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), editou a Súmula Vinculante nº 61, que estabelece parâmetros para o deferimento judicial de tais prestações. Nesse mesmo sentido, o STF, no julgamento do Tema 1234, fixou critérios cumulativos para o reconhecimento do dever estatal de fornecer medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS.

De acordo com os precedentes vinculantes e qualificados acima mencionados, para que seja reconhecido o dever do Estado de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da

moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No caso em apreço, o acervo probatório indica que a parte autora não se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente no que concerne à demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

Verifica-se que, no curso do processo, foram requisitados três pareceres técnicos ao Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (NATJUS), órgão especializado que subsidia as decisões judiciais com informações médicas e farmacológicas baseadas em evidências científicas. Todos os três pareceres foram desfavoráveis à pretensão autoral, sendo que a última peça de apoio (NT 323770, de 17/04/2025), asseverando: (i) O diagnóstico de MIELOFIBROSE conforme dados médicos constantes do processo; (ii) A ausência de laudos de biópsia de medula óssea ou mutação JAK2, conforme solicitado em notas técnicas anteriores; (iii) Que existe parecer técnico definitivo da CONITEC contrário à incorporação da medicação pelo SUS; e (iv) Concluindo-se desfavoravelmente ao provimento da presente solicitação tendo em vista a manifestação negativa da CONITEC, em consonância com o tema 1234 do STF.

As informações prestadas pelo NATJUS, pela natureza técnica inerente, deve, receber o tratamento probatório análogo ao dispensado à prova pericial. Conforme dispõe a doutrina de Daniel Assumpção Amorim, “a prova pericial é meio de prova que tem como objetivo esclarecer fatos que exijam um conhecimento técnico específico para a sua exata compreensão. Como não se pode exigir conhecimento pleno do juiz a respeito de todas as ciências humanas e exatas, sempre que o esclarecimento dos fatos exigir tal espécie de conhecimento, o juízo se valerá de um auxiliar especialista, chamado de perito” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, Juspodivm, 2023, 15ª edição, p. 791).

Nesse aspecto, de rigor notar que não se desconhece que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e, na forma do artigo 479 do Código de Processo Civil, pode indicar na sentença os motivos que o levaram a deixar de considerar as conclusões do laudo.

Entretanto, como bem adverte a doutrina, “*se a prova pericial foi produzida, pressupõe-se a existência de uma controvérsia cuja solução extrapolava os limites da área de conhecimento própria de um juiz,* ***motivo pelo qual é inaceitável que a prova pericial seja simplesmente descartada, desconsiderada, sem que se resolva a controvérsia que justificou a prova técnica ou, pior, dando o julgador solução própria à questão***” (Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, 'in' Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin [coord.], “Comentários ao Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura”, São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 508).

Nesta esteira, aspecto de suma relevância é que o referido documento destacou a existência de parecer técnico definitivo da CONITEC contrário à incorporação da medicação pelo SUS, referindo-se à PORTARIA SCTIE/MS Nº 54, DE 1º DE JULHO DE 2022, que decidiu pela não incorporação do ruxolitinibe para tratamento de pacientes com mielofibrose no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O parecer técnico consigna expressamente que as *"Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não Recomendada"*, concluindo *"desfavoravelmente ao provimento da presente solicitação tendo em vista a manifestação negativa da CONITEC, em consonância com o tema 1234 do STF"*.

Tal decisão da CONITEC possui relevância técnico-científica fundamental, uma vez que este órgão é responsável por assessorar o Ministério da Saúde na incorporação de tecnologias em saúde pelo SUS.

É importante ressaltar que o E. STF tem **orientação vinculante** no sentido de que a intervenção judicial na seara das políticas públicas de saúde deve ser excepcional e pautada por critérios racionais e objetivos, sob pena de comprometer a própria sustentabilidade do sistema público de saúde e a isonomia no acesso aos serviços sanitários. Os julgados a seguir tratam especificamente do fármaco objeto dos autos:

> DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RUXOLITINIBE (JAKAVI). MIELOFIBROSE** PRIMÁRIA DE ALTO RISCO. **IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA**. NEGADO PROVIMENTO. 1 . O direito à saúde, ainda que fundamental, não é absoluto, devendo ser avaliado à luz da reserva do possível, do princípio da equidade e da efetividade das políticas públicas de saúde. 2. A jurisprudência do STJ (Tema 106, REsp 1.657 .156/RJ) e do STF (Tema 6, RE 566.471) estabelece requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo a demonstração da imprescindibilidade clínica, eficácia comprovada com base em evidências científicas robustas, e ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. 3. O medicamento Ruxolitinibe, embora aprovado pela ANVISA, foi avaliado pela CONITEC, que recomendou sua não incorporação ao SUS devido à insuficiência de evidências científicas quanto à sua eficácia em termos de sobrevida global, relação custo-efetividade desfavorável e finalidade paliativa, não substitutiva . 4. **O autor não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões da CONITEC, nem para comprovar a superioridade terapêutica ou a imprescindibilidade do medicamento em seu caso específico**. 5. **A decisão administrativa da CONITEC atende aos requisitos de motivação e fundamentação técnica, não cabendo ao Judiciário substituir-se aos órgãos técnicos especializados na**

formulação de políticas públicas . 6. Diante das circunstâncias e das especificidades do tratamento, em se tratando de medicamento de elevado custo, de finalidade paliativa, cuja eficácia carece de consenso científico, entende-se indevida a sua dispensação, não merecendo reparos a sentença em apreço. 7. Recurso desprovido. (TRF-6 - AC: 10013474720224063825 MG, Relator.: MÔNICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 05/02/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 12/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 06 DO STF. **RUXOLITINIBE. MIELOFIBROSE. CONCESSÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES DA CONITEC**. 1. **O Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído no dia 20-09-2024, fixou a tese de repercussão geral no âmbito Tema 06, enaltecendo substancialmente o papel da CONITEC e impondo a necessidade de que sejam observadas suas decisões, inclusive com vedação à incursão no mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. 2. In casu, o Ministério da Saúde, após criteriosos pareceres da CONITEC (Relatórios n .º 531/2020 e n.º 735/2022), deixou - justificadamente - de incorporar o medicamento RUXOLITINIBE à rede pública de saúde para tratamento de pacientes com mielofibrose (Portarias SCTIE n.º 20, de 12 de junho de 2020 e n.º 54, de 1º de julho de 2022)** . 3. Apelação improvida para manter a sentença de improcedência. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50010873820214047204 SC, Relator.: LUÍSA HICKEL GAMBA, Data de Julgamento: 12/02/2025, 9ª Turma, Data de Publicação: 21/02/2025)

Nesse sentido, a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado pelo médico que assiste o paciente, demonstrando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, constitui requisito essencial para o deferimento judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS.

No caso em tela, verifica-se que a documentação médica acostada aos autos não se mostra suficiente para comprovar de forma técnica e fundamentada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, conforme apontado pelos pareceres técnicos especializados.

Na linha dos precedentes vinculantes, há necessidade de observância dos princípios da medicina baseada em evidências, não sendo suficiente para o deferimento do pedido a mera prescrição médica desacompanhada de elementos técnicos que demonstrem a superioridade terapêutica do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Conforme destacado nos pareceres técnicos, existe no SUS a opção terapêutica da hidroxiureia, medicação disponível no sistema público e com benefícios comprovados para o tratamento da mielofibrose. Os pareceres indicam que, embora o ruxolitinibe possa trazer melhora dos sintomas, menor índice de transfusões e melhora do inchaço do baço comparado à hidroxiureia, não foram demonstrados até o momento melhora consistente da sobrevida com o uso da medicação.

O terceiro parecer técnico é ainda mais enfático ao concluir: *"Não foram demonstrados até o momento, no entanto, melhora consistente da sobrevida com o uso da medicação"*, reforçando que a superioridade do ruxolitinibe em relação à hidroxiureia não está estabelecida em termos de benefício clínico fundamental, qual seja, o aumento da sobrevida dos pacientes.

Ademais, o referido documento esclarece expressamente que o ruxolitinibe *"pode aumentar a sobrevida geral e retardar a velocidade da fibrose, mas não reverte a fibrose existente na maioria dos casos e pode resultar em anemia e baixas contagens de plaquetas"*, demonstrando que mesmo os potenciais benefícios são limitados e acompanhados de efeitos adversos significativos.

Conforme leciona a doutrina tradicional, no processo, a vontade concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes, se demonstrado ficar que os fatos, de onde promanam os efeitos jurídicos que pretende, são verdadeiros. Claro está que, não comprovados tais fatos, advirá para o interessado, em lugar da vitória, a sucumbência e o não reconhecimento do direito pleiteado (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, 8ª edição, Saraiva, São Paulo, 1985, v. 2, p. 193).

A necessidade de provar para vencer, diz Wilhelm Kisch, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma obrigação, e sim de um ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a prova do fato suportará as consequências e prejuízos da sua falta e omissão (Elementos de Derecho Procesal Civil, 1940, p. 205; "apud" José Frederico Marques, ob. cit., p. 193).

No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe cabia, deixando de demonstrar de forma técnica e fundamentada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

A ausência de elementos técnicos suficientes que demonstrem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, aliada à manifestação desfavorável dos três pareceres técnicos especializados e à decisão da CONITEC contrária à incorporação do ruxolitinibe no SUS, conduzem à conclusão de que a pretensão autoral não encontra respaldo no precedente vinculante (Tema 1234, STF), o que impede a sua concessão.

No que toca a eventuais alegações incapazes de infirmar a conclusão da lide e, por essa razão, não apreciadas de maneira exauriente no presente *decisum*, saliento que o art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador o ônus de refutar, indiscriminadamente, todos os fundamentos apresentados pela parte, desde que os que forem apreciados sejam suficientes ao deslinde da causa. Nesse sentido é a interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

> "O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.9.2018, DJe 21.11.2018).

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, observando-se, contudo, que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual a exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em caso de apelação, adote-se as seguintes providências, independentemente de nova conclusão do processo: a) nos termos do artigo 1.010 do CPC, intime-se o(s) APELADO(S) para apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias; b) Se o(s) apelado(s) interpuser(em) apelação adesiva, intime-se o APELANTE para contrarrazões em 15 (quinze) dias; c) decorrido o prazo, a Secretaria, sem fazer nova conclusão do processo, encaminhará os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpridas as formalidades de estilo, inclusive a certificação do trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. Expedientes necessários.

Buíque, datado e assinado eletronicamente.

Felipe Marinho dos Santos

Juiz Substituto